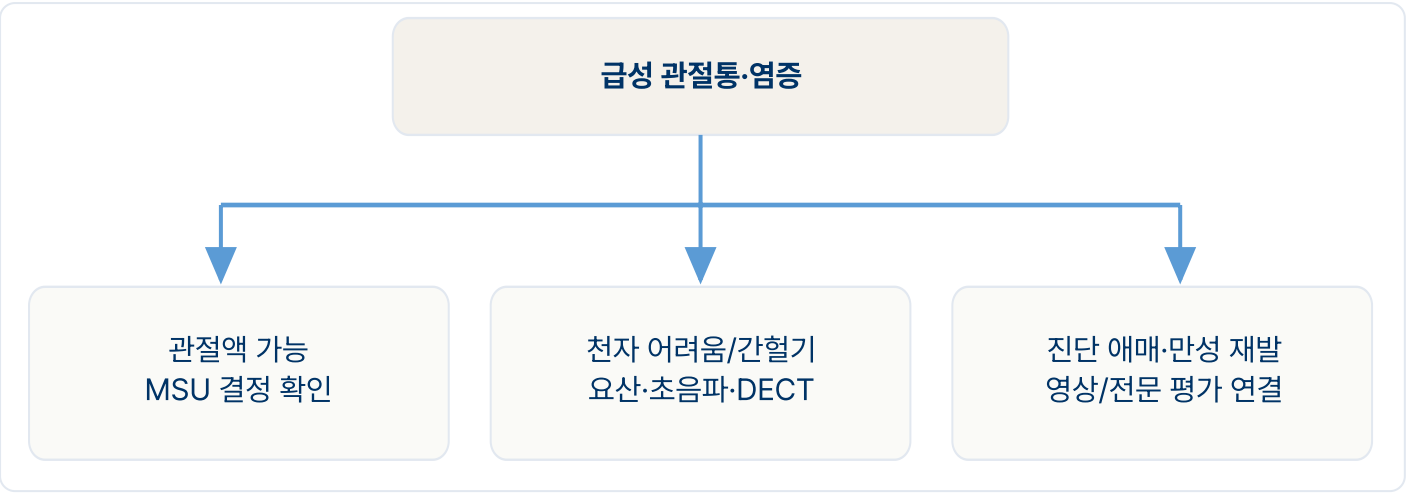
통풍이 의심되는 급성 관절통

병력·염증 양상과 결정/영상 증거를 함께 봅니다



전형적인 임상 양상

급격한 단관절 염증, 제1 MTP·발목/발 침범, 발적·부종, 하루 내 최고조 통증과 과거 발작을 묻습니다. 음주·회식, ULT 시작/중단, 수술·금식·급성 신기능저하·패혈증은 유발 맥락입니다.

검사 선택

가능하면 관절액 MSU 결정을 확인합니다. 간헐기에는 천자가 어려울 수 있어 혈청 요산, 초음파 이중윤곽징후(double contour), DECT 요산 침착, X-ray 골미란을 임상상과 함께 봅니다.

김용길 연자 Q&A · 애매한 발등 통증

발작 당시 podagra·고요산혈증·통증 강도·염증을 확인합니다. 대개 1주 내 완전 소실하며 애매한 통증은 1~2주 경과를 보는 방법을 소개했습니다. 만성 재발성 양상은 DECT로 MSU 침착 평가를 고려합니다.

검사와 급성기 처방의 연결

요산저하제 신규 시작과 기존 유지 치료를 구분

2015 분류 · 강의 제시

임상(관절 패턴 1~2, 특징 1~3, 시간 경과 1~2, 결절 4점), 혈청 요산 −4~4점, 관절액 결정 음성 −2점, 영상 침착/골미란 각각 4점. 총 23점 중 ≥8점입니다. 혈청 요산 ≥10 mg/dL도 4점 항목으로 설명했습니다.

급성기 치료 · 강의 설명

NSAIDs는 s-Cr 확인 후 고려합니다. 신기능저하로 어려우면 PD 30 mg, ≤5일을 소개했고 감염 우려를 주의했습니다. 1~2관절, 특히 큰 관절은 관절강 스테로이드를 고려합니다. 콜히친은 ≤24시간(빠를수록, 강의에서 ≤12시간 강조), 1.2 mg 후 1시간 뒤 0.6 mg 추가, s-Cr 점검입니다.

김용길 연자 Q&A · 콜히친

급성기에는 24시간, 가급적 18시간 내 시작하여 0.6 mg 하루 2회를 답했습니다. 0.6 mg 하루 1회는 예방 목적입니다. 드물게 간수치 상승·혈구감소가 나타날 수 있습니다.

ULT 시작·유지

연자는 급성기에 ULT를 새로 시작하지 않고 안정 후 약 3~4주(연자 Q&A 약 1개월)에 시작한다고 설명했습니다. 이미 ULT 복용 중 발생한 발작에는 ULT를 유지하고 항염 치료를 추가합니다. 갑작스러운 시작·중단은 발작을 유발합니다.